Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Iguatemi
Vara Única

Processo nº 0801390-27.2018.8.12.0035
Classe: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Medicamentos
Autor:Zelir Terezinha Valiati Bernardo
Réu: Município de Iguatemi

Vistos, etc...

Zelir Terezinha Valiati Bernardo, devidamente qualificado(a) nos autos, ingressou com ação de obrigação de fazer em face do **Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Iguatemi-MS,** igualmente qualificados, alegando, resumidamente, que é portadora de osteoartrose generalizada e osteoporose, com acometimento de joelhos, pés e coluna lombar, com queixa de dor acentuada com piora na movimentação, por conta disso, necessita fazer uso dos medicamentos: DORENE 150mg e MANIPULADO (UCII 40mg + TRAMADOL50mg + IBUPROFENO200mg cp/dia), pois a falta destes pode lhe causar dores crônicas.

O NAT lançou parecer às fls. 72-83, opinando de forma desfavorável a concessão dos medicamentos.

Em decisão de fls. 92-95 foi indeferida a liminar.

Citado, o Estado de Mato Grosso do Sul contestou às fls. 108-121, onde rebate os argumentos iniciais, dizendo que não há como obrigar o ente público a fornecer medicamentos não especificados na inicial. Argumentou aplicação da Súmula 421 do STJ, para não pagamento dos honorários.

O Município de Iguatemi-MS contestou às fls. 122-134, requerendo a improcedência do pedido inicial e o afastamento da condenação do Município ao pagamento de astreintes ou multa.

Impugnação à Contestação às fls. 138-155.

É o relatório. Decido:

Inicialmente, é sabido que a orientação do art. 196 da Constituição Federal impõe o reconhecimento de uma solidariedade dos entes públicos na prestação do serviço essencial à saúde.

Nesse sentido:

> *E M E N T A – Apelação Cível – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – MÉRITO – DIREITO À SAÚDE (ARTIGO 196, CF/88) – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E DO ESTADO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR MANTIDO. 1. Hipótese em que se discute: em sede preliminar: a) a ilegitimidade passiva do Município, e no mérito: b) a obrigação do Município de fornecer a cirurgia prescrita à paciente que*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO DA SILVA CASSAVARA, liberado nos autos em 16/11/2019 às 09:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801390-27.2018.8.12.0035 e código a31tbFjK.

não possui condições financeiras de custeá-los, e c) o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles (União, Estado e Município), isoladamente, ou conjuntamente. Precedentes do STF. 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88). Assim, o Estado e o Município não podem se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Precedentes do STF. 4. O valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado em quantia condizente com o serviço desempenhado, o tempo exigido para o serviço, a natureza e a importância da demanda e o grau de zelo do profissional, requisitos estes elencados nos incisos do § 2 o do art. 85 do CPC. Valor mantido
*(**TJMS**. Apelação Cível n. 0802600-58.2018.8.12.0021, Três Lagoas, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 18/07/2019, p: 22/07/2019)*

É sabido que a Constituição Federal garante o direito à saúde, independentemente da urgência. O critério urgência é valorado para (in)deferimento da tutela antecipada. Entretanto, a sentença concretiza o direito, que independe da urgência. Nesse sentido, decidiu o TJ/MT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ARTROLIVE – RECEITA E MÉDICO CREDENCIADO AO SUS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O deferimento da tutela antecipada subordina-se ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 273, do CPC, quais sejam, prova inequívoca da verossimilhança das alegações e fundado receio de lesão grave e de difícil reparação ou, ainda, abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.
2. O parecer do NAT, só por si, não afasta o periculum in mora necessário à concessão da tutela antecipada no caso dos autos, repousando o mesmo na constatação de que o medicamento pleiteado foi prescrito por médico credenciado ao Sistema Único de Saúde.
3. Além disso, a legislação constitucional e infraconstitucional não preveem como condição sine qua non para a concretização do direito à saúde a urgência ou o risco de vida, mas sim a necessidade do tratamento médico.
4. Presentes os requisitos legais necessários, é de ser deferida a tutela antecipada requerida na instância de piso.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO DA SILVA CASSAVARA, liberado nos autos em 16/11/2019 às 09:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801390-27.2018.8.12.0035 e código a31tbFjK.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Iguatemi
Vara Única

(AI 70488/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

O direito à saúde tem previsão constituição, impondo ao Estado em sentido lato – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – a obrigação de atender ao cidadão, como corolário do direito fundamental à saúde e do princípio matriz da dignidade da pessoa humana.

O art. 196 da CF prevê que: *"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."*

A legislação infraconstitucional também impõe esse dever ao Estado (sentido amplo), ao dispor, no art. 2.º da Lei Federal n.º 8.080/90: *"A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício"*.

No caso em tela, de acordo com o Parecer do NAT:

> **XI - Conclusão favorável ou desfavorável ao pedido.**
>
> Considerando que a paciente está sendo atendida por médico especialista particular;
>
> Considerando que Pregabalina 150mg, Colágeno UC II 40mg + Tramadol 50mg + Ibuprofeno 200mg não estão padronizados na RENAME;
>
> Considerando o PCDT para Dor Crônica, Portaria SAS/MS nº 1083, de 02 de outubro de 2012, que oferece Ácido Acetilsalicílico, Dipirona, Paracetamol, Ibuprofeno, Amitriptilina, Nortriptilina, Clomipramina, Fenitoína, Carbamazepina, Gabapentina, Ácido Valproico, Codeína, Morfina, Metadona, sendo que a paciente não está cadastrada;
>
> Considerando que a RENAME tem padronizado no CBAF medicamentos analgésicos (dipirona sódica e paracetamol), anti-inflamatório (ibuprofeno), corticoides sistêmicos (dexametasona, ésteres de betametasona, prednisona, prednisolona), antidepressivos (cloridrato de amitriptilina, nortriptilina, clomipramina e fluoxetina), anticonvulsivantes (ácido valproico, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina), vitaminas (tiamina, piridoxina, cianocobalamina), antipsicóticos (clorpromazina, haloperidol), ansiolíticos (clonazepam, diazepam);
>
> Considerando as evidências científicas descritas no item III;
>
> Considerando a falta de informações sobre tratamentos anteriores realizados pela pacientem bem como não foram apresentados resultados de exames complementares;
>
> Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é desfavorável do pedido de Pregabalina 150mg, Colágeno UC II 40mg + Tramadol 50mg + Ibuprofeno 200mg.

O STJ em recurso repetitivo fixou a seguinte tese: ***"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento."*** (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO DA SILVA CASSAVARA, liberado nos autos em 16/11/2019 às 09:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801390-27.2018.8.12.0035 e código a31tbFjK.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Iguatemi
Vara Única

Verifica-se que de acordo com o postulado pela autora, os medicamentos não estão incluídos no RENAME, sendo que não existe efetiva demonstração médica da imprescindibilidade dos fármacos, tampouco informação da utilização dos medicamentos fornecidos pelo SUS, impondo, por conseguinte, a improcedência dos pleitos iniciais.

Nesse sentido:

> *E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CARDÍACA – PARECER DESFAVORÁVEL DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO – MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) – EXISTÊNCIA DE OUTROS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 01. Considerando que os medicamentos pleiteados não estão padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e, havendo parecer desfavorável do Núcleo Técnico (NAT), deve ser mantido o decreto de improcedência. Some-se a isso a necessária observância dos Enunciados sobre Direito da Saúde da I Jornada realizada em São Paulo pelo Conselho Nacional de Justiça, no caso, notadamente os de números 11, 16 e 31. 02. Recurso conhecido e desprovido.*
> *(**TJMS**. Apelação Cível n. 0800155-18.2019.8.12.0026, Bataguassu, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 25/09/2019, p: 26/09/2019)*

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, razão porque extingo o processo com análise de mérito, na forma do que disciplina o art. 487, I, do CPC.**

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, ficando a exigibilidade das verbas suspensas na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Ciência à DPE e as Procuradorias do Estado e do Município.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Iguatemi, 16 de novembro de 2019.

Marcelo da Silva Cassavara
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO DA SILVA CASSAVARA, liberado nos autos em 16/11/2019 às 09:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801390-27.2018.8.12.0035 e código a31tbFjK.